

Curso

**ATENÇÃO À SAÚDE DA
CAMINHONEIRA E
CAMINHONEIRO NA ATENÇÃO
PRIMÁRIA**

Módulo I

O Cuidado da Caminhoneira e do
Caminhoneiro na Atenção Primária à
Saúde

AUTORAS

Ana Luiza Machado Pinto (<http://lattes.cnpq.br/6138366139843524>)

Mariângela Carmo Valente (<http://lattes.cnpq.br/6654827763556363>)

SUMÁRIO

Apresentação do módulo

1.1 A Atenção Primária à Saúde e o cuidado à caminhoneira e ao caminhoneiro	3
1.2 Gênero, trabalho nas estradas e políticas de atenção à saúde	8
1.3 Educação em saúde e promoção do cuidado	11
1.4 Vigilância em saúde e a saúde do trabalhador e da trabalhadora nas estradas	12
1.5 Organização do cuidado, territorialização e articulação da rede	14
Encerramento do módulo	15
Referências	16

APRESENTAÇÃO DO MÓDULO

Prezado profissional estudante, é com grande satisfação que damos início ao Curso de Atenção à Saúde da Caminhoneira e Caminhoneiro na Atenção Primária. Bem-vindo ao Módulo II!

Este módulo foi desenvolvido para apresentar a realidade das caminhoneiras e dos caminhoneiros, considerando os desafios de sua rotina, como longos períodos longe de casa, jornadas exaustivas e restrições de tempo para acessar serviços de saúde. O objetivo é focar o cuidado a essa população na Atenção Primária à Saúde (APS), apoiando a prática dos profissionais de saúde e integrando conhecimentos técnicos e demandas específicas desse público.

Ao longo do módulo serão apresentados conteúdos relacionados ao acolhimento e à organização do cuidado na APS, com destaque para intervenções direcionadas às necessidades das caminhoneiras e dos caminhoneiros, bem como práticas de promoção de saúde. Também serão discutidos fatores como gênero, estilo de vida e condições de trabalho, os quais influenciam o processo saúde-doença.

Cuidar dessa população demanda atenção, formação contínua e respeito. Por isso, esperamos que este conteúdo possa aprimorar sua prática e fortalecer todo o processo de cuidado. Vamos juntos nessa estrada?

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

1. Compreender os atributos da Atenção Primária à Saúde na perspectiva do cuidado à saúde das caminhoneiras e dos caminhoneiros.
2. Reconhecer o papel da equipe de Saúde da Família na coordenação do cuidado em saúde das caminhoneiras e dos caminhoneiros, considerando as especificidades de acesso e circulação dessa população.
3. Reconhecer o papel das equipes de Atenção Primária à Saúde no acolhimento e na promoção do cuidado integral das caminhoneiras e dos caminhoneiros.
4. Compreender como os princípios e diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem e da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher se articulam na atenção à saúde da população caminhoneira.
5. Compreender as estratégias de educação e de promoção da saúde como componentes

do cuidado integral das caminhoneiras e dos caminhoneiros.

6. Compreender a vigilância em saúde na perspectiva do cuidado na Atenção Primária à Saúde das caminhoneiras e dos caminhoneiros.
7. Identificar estratégias de organização do cuidado na Atenção Primária à Saúde voltadas ao público caminhoneiro.
8. Reconhecer questões de gênero que atravessam o trabalho, o viver e o cuidar em saúde das caminhoneiras e dos caminhoneiros.

CARGA HORÁRIA DE ESTUDO

07 horas.

1.1 A Atenção Primária à Saúde e o cuidado às caminhoneiras e aos caminhoneiros

A Atenção Primária à Saúde (APS) é a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo responsável pela coordenação do cuidado e organização da Rede de Atenção à Saúde (RAS) (Starfield, 2002). No Brasil, tem como modelo prioritário a Estratégia Saúde da Família (ESF), com base territorial e foco na responsabilidade sanitária esse contexto, compreender os atributos essenciais e derivados da APS (Starfield, 2002) contribui para qualificar o cuidado ofertado e fortalecer práticas integrais e coordenadas em diferentes territórios e realidades sociais.

Você conhece os atributos essenciais e derivados da APS?

- Essenciais: acesso de 1º contato, longitudinalidade, integralidade e coordenação do cuidado.
- Derivados: orientação familiar, orientação comunitária e competência cultural.

Diante disso, é importante refletir: qual o papel da APS no cuidado dessa população, e como garantir o seu acesso integral em todo o território nacional?

Ao longo desta unidade, propomos uma reflexão a respeito de como os atributos da APS podem ser mobilizados no cuidado à caminhoneira e ao caminhoneiro, considerando a necessidade de uma organização do cuidado flexível e sensível às suas condições de vida e trabalho.

Muitas vezes, o acesso aos serviços ocorre fora do território de residência, de forma pontual e condicionada ao tempo disponível e à imprevisibilidade da rotina nas estradas. Ainda assim, o território adscrito, vinculado a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência, permanece como ponto central na coordenação e continuidade do cuidado (Brasil, 2017). Mesmo quando há atendimentos em outros serviços ao longo do território, essa UBS mantém o papel central na coordenação e continuidade do cuidado. Além disso, em consonância com os princípios da universalidade e da equidade, a população caminhoneira pode acessar serviços de APS em todo o território nacional durante sua jornada de trabalho.

Para grupos como desse público, a coordenação do cuidado torna-se desafiadora devido ao tempo prolongado fora de casa e às longas jornadas de trabalho. Que tal conhecer um pouco mais sobre a realidade vivida por estes profissionais?

Os atributos da APS orientam tanto o vínculo com a equipes de referência da UBS quanto o acesso oportuno a outros pontos da RAS, como demonstrado no quadro a seguir.

Quadro 1. Organização dos atributos da APS no cuidado à população caminhoneira

Atributos Essenciais da APS	UBS de referência do território adscrito	Qualquer unidade de saúde em âmbito nacional
Acesso de 1º contato: Caracteriza-se pela garantia de acesso oportuno e resolutivo a cada nova necessidade de saúde da população.	Garantir acesso oportuno, com agendamento de acordo com a rotina e agenda de trabalho. Isso se aplica para as consultas de rotina e exames laboratoriais e de imagem. Exemplo: se existe a necessidade de realização de exames laboratoriais solicitados pelo médico da eSF, garantir a realização em tempo oportuno para a avaliação da equipe.	Garantir acesso oportuno e resolutivo para as queixas agudas e espontâneas, bem como para atendimentos eletivos, se necessários. Exemplo: houve busca ativa de uma pessoa caminhoneira para renovação de receita de medicamentos anti-hipertensivos. A unidade deve garantir acolhimento com escuta sensível e resolutiva, pois a barreira de acesso pode indicar a descontinuidade no tratamento da hipertensão arterial sistêmica (HAS).
Longitudinalidade: Caracteriza-se pela APS como uma fonte regular de atenção à saúde, ao longo do tempo, estabelecendo vínculo entre usuário e equipe de saúde, assegurando a continuidade do cuidado.	Garantir acompanhamento contínuo da caminhoneira e do caminhoneiro ao longo do tempo, mesmo diante dos períodos fora do território. A equipe deve manter registro atualizado, acompanhar condições crônicas, monitorar tratamentos e organizar o plano de cuidado de forma compatível com os períodos em que o usuário está no território. Exemplo: organizar consultas e exames em momentos em que esteja em seu local de residência, além de reforçar a possibilidade de cuidado e acesso a qualquer UBS próxima do seu local de parada e descanso.	Garantir o atendimento qualificado, registrando as informações no prontuário e orientando quanto à continuidade do cuidado. Exemplo: atendimento de uma pessoa caminhoneira em outra cidade para controle de pressão arterial, com registro da consulta e orientação para seguimento do cuidado.

Integralidade: Refere-se à oferta de ações de promoção da saúde, prevenção de doenças, diagnóstico, tratamento e reabilitação, considerando as necessidades de saúde da pessoa de forma ampla e articulada.	Identificar e abordar as diversas necessidades de saúde da caminhoneira e do caminhoneiro, considerando suas condições de vida e trabalho, incluindo vigilância de agravos relacionados à atividade laboral, saúde mental, saúde sexual e reprodutiva, doenças crônicas e agravos agudos. Exemplo: realização de avaliação integral de saúde que considere alimentação irregular, privação de sono, sedentarismo, risco cardiovascular e saúde mental.	Ofertar cuidado resolutivo frente às necessidades apresentadas, considerando tanto a queixa imediata quanto outros aspectos relevantes da saúde da população caminhoneira. Exemplo: durante atendimento por dor lombar, avaliar fatores ocupacionais relacionados à atividade de dirigir por longos períodos e orientar medidas de prevenção.
Coordenação do cuidado: Caracteriza-se pela capacidade da APS de organizar o cuidado do usuário na RAS, articulando diferentes serviços e níveis de atenção para garantir continuidade e resolutividade.	Assumir a responsabilidade pela coordenação do cuidado da pessoa caminhoneira, organizando encaminhamentos, acompanhando resultados de exames e consultas especializadas e integrando informações obtidas em atendimentos realizados em outros serviços da rede. Exemplo: quando necessário, a eSF realizará encaminhamento para especialista — e deve organizar essa solicitação na RAS, de modo que seja agendada a consulta para período em que o usuário esteja em seu território de residência, o que contribui para o acompanhamento posterior.	Realizar o atendimento necessário e registrar as informações de forma adequada, orientando o usuário sobre a importância de compartilhar essas informações com sua equipe de referência, o que promove a continuidade do cuidado. Exemplo: em atendimento em unidade de saúde durante viagem por quadro de crise hipertensiva, deve haver registro da conduta adotada e orientação para seguimento e reavaliação pela eSF de referência no território do usuário.
Orientação familiar: Refere-se à consideração da família como um importante contexto para compreensão das condições de saúde e para	Considerar o contexto familiar da caminhoneira e do caminhoneiro no planejamento do cuidado, identificando impactos da atividade laboral nas relações familiares e no apoio ao tratamento e autocuidado.	Reconhecer a importância do contexto familiar nas orientações de saúde e, sempre que possível, orientar o usuário a compartilhar informações e estratégias de cuidado com seus familiares.

o planejamento do cuidado.	Exemplo: orientar familiares sobre apoio ao controle de doenças crônicas durante os períodos em que a pessoa caminhoneira retorna ao domicílio.	Exemplo: orientar sobre adesão ao tratamento medicamentoso considerando apoio familiar.
Orientação comunitária: Refere-se à capacidade da APS de reconhecer as necessidades de saúde da comunidade e desenvolver ações a partir da realidade social, econômica e cultural do território.	Reconhecer as especificidades da população caminhoneira presente no território e desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de agravos voltadas a esse grupo. Exemplo: ações educativas sobre saúde cardiovascular, alimentação saudável e prevenção de IST em locais frequentados por caminhoneiras e caminhoneiros.	Reconhecer que o público caminhoneiro compõe um grupo populacional com necessidades específicas e garantir acolhimento e orientações adequadas à sua realidade laboral e social. Exemplo: realização de ações de saúde em unidades próximas a estradas ou pontos de parada.
Competência cultural: Refere-se à capacidade dos profissionais e serviços de saúde de reconhecer e respeitar as características culturais, sociais e os modos de vida das populações atendidas.	Compreender as particularidades do modo de vida da população caminhoneira, incluindo rotinas de trabalho, alimentação, sono e deslocamento constante, adaptando estratégias de cuidado e acompanhamento. Exemplo: flexibilização de agendas e organização do acompanhamento que considere os períodos de permanência no território.	Oferecer cuidado respeitoso e sensível às condições de vida e trabalho da caminhoneira e do caminhoneiro, evitando julgamentos e considerando as limitações impostas pela atividade laboral. Exemplo: orientar estratégias possíveis de autocuidado durante as jornadas de trabalho.

Fonte: elaboração das autoras, 2026, com base em Starfield, 2002 e Brasil, 2017.

O quadro mostra como os atributos da APS orientam o cuidado às caminhoneiras e aos caminhoneiros, reconhecendo suas singularidades para organizar um cuidado resolutivo e garantir acesso oportuno aos serviços de saúde.

Reflexão

Pensando na organização do cuidado em sua realidade de trabalho, reflita:

- De que forma os serviços de saúde têm se organizado para acolher caminhoneiras e caminhoneiros?
- Como a avaliação de risco pode apoiar decisões mais adequadas no primeiro contato com esses usuários?
- Quais estratégias podem contribuir para fortalecer a continuidade e a coordenação do cuidado, mesmo quando o acompanhamento ocorre de forma intermitente?

No atendimento da APS, uma pergunta deve orientar sua ação: há risco imediato à saúde desse paciente? A classificação de risco é a ferramenta que auxilia na organização do cuidado na definição de prioridades. De acordo com o Ministério da Saúde, essa avaliação deve considerar não apenas a gravidade clínica imediata, mas também as vulnerabilidades e o contexto de vida do usuário (Brasil, 2013b). Antes de tudo, lembre-se: a classificação de risco deve ser realizada em todo atendimento por demanda espontânea.

Imagine a cena: uma pessoa caminhoneira chega na UBS dizendo que “não está se sentindo bem”. Por onde começar? Você pode organizar a avaliação a partir de alguns passos:

- escutar: o que a pessoa está sentindo? Há quanto tempo?;
- observar sinais: nível de consciência, dificuldade para falar ou respirar;
- verificar sinais vitais: pressão arterial, frequência cardíaca, temperatura, glicemia;
- identificar sinais de alerta: dor intensa, falta de ar, confusão mental, desmaios e outros;
- considerar se: dormiu bem, está se alimentando, faz uso regular de medicação;
- definir a prioridade do atendimento: imediato, prioritário ou pode aguardar.

Agora, pense no seguinte caso: Uma pessoa caminhoneira relata dor “leve” no peito, associada ao cansaço, após muitos dias dirigindo e dormindo pouco. Diante desse relato, como proceder?

Mesmo que a dor pareça leve, esse é um caso que exige atenção, de modo que a classificação de risco deve considerar os passos citados e a possibilidade de agravamento. Perceba que a classificação de risco não depende apenas da intensidade da queixa, mas também da combinação entre sinais clínicos e contexto.

Além da conduta imediata, deve-se registrar o atendimento, orientar sinais de alerta e indicar quando e onde buscar o cuidado. Assim, a classificação de risco deixa de ser apenas uma triagem e torna-se um momento estratégico que pode evitar agravamentos e qualificar toda a atenção prestada.

1.2 Gênero, trabalho nas estradas e políticas de atenção à saúde

Compreender as especificidades das caminhoneiras e dos caminhoneiros requer considerar que sua mobilidade constante e longas jornadas são fatores que impactam diretamente o acesso, o vínculo e a continuidade do cuidado. Ademais, nesse contexto a perspectiva de gênero demarca experiências de adoecimento e interage com outros marcadores sociais, reproduzindo múltiplas condições de desigualdades.

Historicamente, o transporte rodoviário de cargas é um trabalho predominantemente masculino, com reflexos diretos no uso dos serviços e panorama de saúde desse grupo. Somam-se a isso os padrões de masculinidade que valorizam resistência e autossuficiência, contribuindo para a baixa procura por ações preventivas, de modo que a busca por cuidado ocorre, em geral, em situações agravadas (Silva *et al.*, 2022). Ainda, condições de trabalho adversas e barreiras organizacionais amplificam as vulnerabilidades e iniquidades.

Caso clínico – Paradas na estrada

Imagine que você atenda em uma UBS: Carlos, 46 anos, caminhoneiro, em demanda espontânea, refere cefaleia, tontura e cansaço. Relata estar há 15 dias na estrada, com privação de sono, alimentação irregular e uso irregular de medicação anti-hipertensiva.

Exame clínico: PA = 178/110 mmHg; Glicemia capilar = 168 mg/dL.

Avaliação de risco e conduta: Como classificar o risco? Trata-se de urgência hipertensiva? Quais condutas imediatas devem ser adotadas na APS (avaliação de sinais de alarme, manejo medicamentoso, observação e encaminhamento)?

Durante o atendimento, o usuário relata: *“Na estrada é difícil manter a rotina, às vezes não dá tempo nem de parar...”*

Plano de cuidado: Como propor um plano de cuidado possível (considerando rotina irregular, mobilidade e acesso intermitente aos serviços)? Quais estratégias podem ser utilizadas para a continuidade do cuidado (registro, comunicação entre serviços e/ou uso de medicação de posologia facilitada)?

No mesmo dia, você atende Juliana, 38 anos, caminhoneira, que refere cansaço persistente, ansiedade e dificuldade para dormir. Relata insegurança nas paradas em estradas e dificuldade de acesso a serviços de saúde.

Abordagem ampliada e gênero: Quais aspectos considerar para além da queixa principal? Como incorporar questões de gênero (saúde mental, segurança, violência, sobrecarga e barreiras de acesso)? Que intervenções são possíveis na APS nesse contato (acolhimento, escuta qualificada, estratificação de risco, orientações práticas e articulação com a rede)?

Reflexão final: Se esse fosse o único contato com essas duas pessoas, você conseguiria garantir um cuidado resolutivo e possível?

Resposta esperada: Carlos apresenta quadro de risco elevado, compatível com urgência hipertensiva, exigindo avaliação imediata, monitoramento, manejo medicamentoso e possível encaminhamento; devendo-se orientar sobre sinais de alerta e reforçar a adesão ao tratamento. No caso de Juliana, a abordagem deve ser ampliada, considerando aspectos de saúde mental, privação de sono, insegurança nas estradas e possíveis situações de violência. Em ambas as situações é preciso haver escuta qualificada, acolhimento e orientação prática, além da avaliação de risco e da articulação com a rede quando necessário. Lembre-se de que, mesmo em atendimentos pontuais, é importante registrar as informações, orientar o seguimento do cuidado e propor estratégias factíveis de autocuidado.

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) orienta a APS na organização do cuidado a homens, reconhecendo sua menor utilização dos serviços e maiores taxas de morbimortalidade por causas evitáveis. Nesse sentido, tem como objetivo geral promover a melhoria das condições de saúde da população masculina brasileira, contribuindo, de modo efetivo, para a redução da morbidade e da mortalidade desse público. Isso se dá por meio do enfrentamento aos fatores de risco e vulnerabilidades, promovendo o acesso às ações e aos serviços de atenção integral à saúde e respeitando as diferentes expressões de masculinidades.

A política recomenda estratégias para ampliar o acesso, fortalecer o acolhimento e considerar o trabalho como fator central na saúde e no adoecimento, reafirmando o papel da APS como coordenadora do cuidado, mesmo diante da alta mobilidade desses trabalhadores (Brasil, 2008).

A presença crescente de mulheres caminhoneiras adiciona complexidade às demandas de cuidado, evidenciando a necessidade de abordagem sensível às questões de gênero. Elas enfrentam desafios como inserção em um setor historicamente masculinizado, sobrecarga de responsabilidades sociais e familiares, além de situações de discriminação e vulnerabilidade. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) orienta o cuidado com

base em direitos, equidade e integralidade, considerando determinantes sociais, condições de trabalho, saúde mental e situações de violência (Brasil, 2004).

A incorporação dessas diretrizes permite à APS oferecer um cuidado integral, contínuo e equânime às caminhoneiras e aos caminhoneiros, considerando gênero, trabalho e mobilidade como dimensões centrais do processo saúde-doença (Brasil, 2008; Brasil, 2004). Essas políticas orientam o cuidado de populações que enfrentam barreiras de acesso e desigualdades, destacando a ampliação do acesso, o acolhimento e ações de promoção e prevenção, bem como práticas baseadas na integralidade, equidade e garantia de direitos, contemplando condições de vida e trabalho, saúde mental e situações de vulnerabilidade.

Esses referenciais podem ser aplicados na APS para apoiar o cuidado de pessoas em constante deslocamento, ajudando a adaptar as práticas a diferentes contextos e promovendo um cuidado integral e equitativo.

1.3 Educação em saúde e promoção do cuidado

A educação em saúde é uma estratégia central da APS para promover o cuidado integral e fortalecer a autonomia dos usuários. Mais do que transmitir informações, envolve diálogo, escuta e construção compartilhada, aqui considerando as condições de vida e trabalho nas estradas. Essa abordagem é recomendada pela Política Nacional de Educação Popular em Saúde (PNEPS-SUS) (Brasil, 2013a), que orienta a adaptação das estratégias às realidades dos usuários.

Ao atuar na APS, é importante você considerar: como adaptar sua abordagem educativa para alguém que passa grande parte do tempo em trânsito e não consegue manter uma rotina de cuidados?

No caso da população caminhoneira, as ações educativas podem abordar temas como doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), saúde mental, infecções sexualmente transmissíveis (IST) e vacinação. Para serem mais efetivas, devem ir além das UBS, alcançando espaços estratégicos como locais com grande concentração de caminhoneiras e caminhoneiros, postos de combustível e Pontos de Parada e Descanso (PPD). Nesse contexto, as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) podem contribuir para a promoção do cuidado, especialmente no manejo do estresse, na melhora do sono e no bem-estar, sendo recomendável aplicar essas práticas e buscar formações específicas.

Saiba mais

As PICS fazem parte da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS e incluem abordagens terapêuticas que podem contribuir para prevenção de agravos e cuidado integral das pessoas. Entre as práticas ofertadas no SUS estão: acupuntura, auriculoterapia, meditação, yoga, práticas corporais, fitoterapia, entre outras.

Conheça mais sobre as PICS no SUS em: www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/pics.

Na prática, isso envolve ações objetivas e compatíveis com o tempo disponível, como: orientações breves sobre autocuidado, estratégias para sono e saúde mental, uso de materiais impressos e digitais (como QR Code) e ações educativas realizadas em locais de circulação de caminhoneiras e caminhoneiros.

Imagine a seguinte situação: numa ação em um posto de combustível, você atende uma pessoa caminhoneira com queixa de cansaço e poucas horas de sono. Como você organizaria uma abordagem breve, mas significativa, que gere impacto nesse contato?

Reflexão

Considerando a rotina de longos períodos na estrada, quais estratégias você adotaria para garantir que essa pessoa receba informações sobre prevenção de DCNT, saúde mental e sono, sem comprometer sua rotina? Quais recursos (digitais, impressos e presenciais) poderiam ampliar o alcance dessas ações?

Sabia que parcerias com o Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST SENAT) podem viabilizar campanhas itinerantes de vacinação e ações educativas em momentos de pausa e descanso de caminhoneiras e caminhoneiros? Essas ações tornam-se ainda mais potentes quando você articula parcerias com diferentes setores. Por exemplo, campanhas realizadas em conjunto com empresas de logística ou sindicatos podem ampliar o alcance das orientações e facilitar o acesso aos serviços.

Nesse contexto, a articulação intersetorial com órgãos do setor de transportes, instituições de fiscalização, empresas de logística, sindicatos e associações de caminhoneiras e caminhoneiros é estratégica para ampliar o alcance das ações de promoção da saúde, prevenção de agravos e melhoria das condições de trabalho.

Dica

Ao desenvolver ações de educação em saúde com a população caminhoneira, procure adaptar a linguagem, o tempo e o formato das orientações à realidade de trabalho nas estradas. Muitas vezes, o contato com os serviços de saúde ocorre durante paradas rápidas ou atendimentos pontuais. Nessas situações, orientações objetivas, materiais educativos de fácil consulta e conversas breves sobre autocuidado podem ser mais efetivas para promover reflexão e estimular práticas de cuidado no cotidiano.

Sempre que possível, aproveite o momento do atendimento para abordar temas prioritários, valorizando o diálogo e as experiências trazidas pelos próprios usuários.

Saiba mais

O Ministério da Saúde publicou a *Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS)* em 2018, como anexo da Portaria de Consolidação das normas sobre as políticas nacionais de saúde do SUS. Nesse documento, você poderá se orientar quanto a ações de promoção da saúde no SUS, com foco em prevenção e atenção integral à população.

Disponível em:

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_promocao_saude.pdf.

1.4 Vigilância em saúde e a saúde do trabalhador e da trabalhadora nas estradas

A vigilância em saúde envolve ações contínuas voltadas à identificação, análise e enfrentamento de problemas que impactam a saúde da população, articulando ações de promoção, prevenção e cuidado (Brasil, 2014; Brasil, 2011). Na APS, orientam o cuidado, o planejamento das equipes e a capacidade de respostas às necessidades do território (Brasil, 2011). No caso do público caminhoneiro, a vigilância assume papel estratégico diante dos riscos relacionados ao trabalho, ao estilo de vida e à intensa mobilidade.

No dia a dia, ao atender uma caminhoneira ou um caminhoneiro, você não lida apenas com uma queixa imediata, mas também identifica riscos e contribui para a continuidade do cuidado. Mesmo em atendimentos breves, é possível incorporar ações de vigilância, como: verificação da situação vacinal e identificação de fatores de risco, tais como sinais de fadiga,

sofrimento mental, privação de sono e estresse ocupacional. Essas informações qualificam o cuidado e subsidiam notificações.

A imunização é um exemplo dessa integração. Imagine um atendimento no qual a pessoa relate ter iniciado o esquema vacinal contra hepatite B, mas não sabe se completou as doses. O profissional da saúde deve avaliar o histórico e atualizar o esquema vacinal, reforçando a importância da sua conclusão, mesmo que em diferentes serviços ao longo das estradas.

Estudos apontam que caminhoneiras e caminhoneiros apresentam maior prevalência de DCNT, como hipertensão arterial, diabetes mellitus e obesidade, além de agravos relacionados às condições de trabalho, como distúrbios osteomusculares, fadiga crônica e problemas relacionados ao sono (Freitas *et al.*, 2018). Nesse contexto, longas jornadas, privação de sono, pressão por prazos, exposição a acidentes e condições inadequadas de descanso podem gerar distúrbios osteomusculares, fadiga, estresse ocupacional e problemas cardiovasculares (Souza; Virgens, 2013). Esses fatores podem impactar o bem-estar físico e mental, exigindo atenção das equipes na identificação precoce de riscos — questões que serão abordadas em maior profundidade nos próximos módulos.

No campo da saúde do trabalhador — compreendida como um conjunto de ações no âmbito do SUS voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde dos trabalhadores, considerando os determinantes e condicionantes relacionados aos processos e ambientes de trabalho —, a vigilância envolve identificar e acompanhar agravos relacionados ao trabalho, como: acidentes de trânsito, lesões musculoesqueléticas, estresse ocupacional e problemas de saúde mental.

A APS tem papel importante na identificação desses agravos, na notificação dos casos nos sistemas de informação em saúde e no acompanhamento das pessoas afetadas, contribuindo para a produção de dados que permitam compreender melhor a realidade desse grupo de trabalhadores e orientar políticas públicas de prevenção e promoção da saúde (Souza; Virgens, 2013). Lembre-se de que a notificação no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) deve ser realizada independentemente do local de origem do usuário, com orientação para continuidade do cuidado.

A vigilância em saúde da população caminhoneira exige articulação entre saúde, trabalho e transporte para promover condições mais seguras nas estradas. Mais do que procedimentos, essa junção amplia o olhar sobre o cuidado ao integrar identificação de riscos, orientações, notificação e ações intersetoriais.

Na sua prática, quais dessas ações já estão incorporadas? O que ainda pode ser incluído no seu cotidiano?

Saiba mais

Consulte o livro *Vigilância em Saúde*, da Coleção Para Entender a Gestão do SUS, publicado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) em 2011. Nele, são apresentados conceitos de vigilância epidemiológica, sanitária e da saúde do trabalhador.

Disponível em: www.conass.org.br/bibliotecav3/pdfs/colecao2011/livro_5.pdf.

1.5 Organização do cuidado, territorialização e articulação da rede

A APS se organiza a partir do princípio da territorialização, que estabelece a responsabilidade das equipes sobre uma população adscrita a um território definido (Brasil, 2017). No caso de caminhoneiras e caminhoneiros, surge um desafio: como garantir a continuidade do cuidado para quem está em circulação constante entre diferentes regiões?

Embora o vínculo esteja associado ao território de residência, esses usuários frequentemente acessam serviços fora de sua área. Para isso, a APS deve adotar estratégias como flexibilização de agendas, orientação sobre serviços disponíveis e fortalecimento da comunicação entre unidades (Starfield, 2002; Giovanella; Franco; Almeida, 2020).

A coordenação do cuidado pela APS deve ser central, integrando informações entre serviços e territórios. Registros adequados permitem o acompanhamento do usuário, monitorando resultados e acompanhamento de condições crônicas, mesmo quando parte dos atendimentos ocorre em diferentes locais.

Agora, vamos retomar o caso clínico “**Paradas na estrada**”, apresentado na seção 1.2, para refletir sobre a continuidade do cuidado na prática. Você se lembra do Carlos, caminhoneiro, atendido em uma UBS com queixa de cefaleia, tontura e pressão arterial elevada? Após o manejo inicial, surge um desafio importante no seu cuidado: como garantir essa continuidade para alguém que está sempre em deslocamento?

Durante a conversa, Carlos diz: “Minha unidade de saúde é em outra cidade... mas quase não paro por lá.” Diante dessa situação, você precisa ir além da queixa imediata. Que informações precisam estar no registro para permitir o seguimento por outra equipe? Como você pode atuar de forma flexível diante dessa mobilidade, articulando a rede de atenção?

Quais orientações práticas podem ser oferecidas ao usuário para favorecer esse acompanhamento?

A conduta esperada para o caso descrito, na prática, seria registro completo, plano de cuidado simplificado, prescrição compatível com a rotina e orientação sobre sinais de alerta que contribuem para reduzir a fragmentação do cuidado. Lembre-se de que, mesmo em atendimentos pontuais, é possível atuar de forma resolutiva e fortalecer o vínculo.

A APS também atua articulada à Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (PNSTT), identificando e acompanhando agravos relacionados ao trabalho (Brasil, 2013b).

Programas como Agora Tem Especialistas ampliam o acesso à atenção especializada e fortalecem a integração da rede (Brasil, 2025), favorecendo a continuidade do cuidado mesmo em contextos de mobilidade. Assim, a organização do cuidado na APS, aliada à territorialização e à articulação em rede, permite um cuidado integral, contínuo e adaptado à realidade da população caminhoneira.

ENCERRAMENTO DO MÓDULO

Ao longo deste módulo, você pôde revisitar aspectos conceituais e organizacionais de serviços da APS que são fundamentais para a promoção do cuidado integral às caminhoneiras e aos caminhoneiros, diante das suas especificidades. Ainda, considerando que os contatos desse público com os serviços de saúde ocorrem, na maioria das vezes, de maneira breve, toda e qualquer oportunidade é única para: acolhimento qualificado, educação em saúde, verificação da situação vacinal ou identificação de agravos relacionados ao trabalho, o que pode fazer grande diferença na trajetória de saúde dessas pessoas.

Portanto, cuidar de quem vive nas estradas é, também, reconhecer a importância social do trabalho que realizam e assegurar que o direito à saúde esteja presente em todos os caminhos. Esperamos que este módulo tenha ajudado você a ampliar seu olhar sobre as necessidades da população caminhoneira e a inspirar práticas cada vez mais sensíveis, resolutivas e comprometidas com a integralidade do cuidado.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher**: princípios e diretrizes. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2004. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nac_atencao_mulher.pdf. Acesso em: 16 mar. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. **Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem**: princípios e diretrizes. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2008. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_atencao_saude_homem.pdf. Acesso em: 16 mar. 2026.

BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS). **Vigilância em Saúde**: parte 1. Brasília, DF: CONASS, 2011. [Coleção Para Entender a Gestão do SUS, v. 5]. Disponível em: www.conass.org.br/bibliotecav3/pdfs/colecao2011/livro_5.pdf. Acesso em: 16 mar. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.761, de 19 de novembro de 2013. Institui a Política Nacional de Educação Popular em Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (PNEPS-SUS). **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 20 nov. 2013a. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2761_19_11_2013.html. Acesso em: 4 maio 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. **Acolhimento à demanda espontânea**: Queixas mais comuns na Atenção Básica. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2013b. [Cadernos de Atenção Básica, n. 28, v. 2]. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/acolhimento_demanda_espontanea_queixas_comuns_cab28v2.pdf. Acesso em: 13 abr. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS)**: Revisão da Portaria MS/GM nº 687, de 30 de março de 2006. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2014. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pnps_revisao_portaria_687.pdf. Acesso em: 16 mar. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 22 set. 2017. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html. Acesso em: 25 maio 2026.

BRASIL. Medida Provisória nº 1.301, de 30 de maio de 2025. Institui o Programa Agora Tem Especialistas. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 31 maio 2025. Disponível em: www2.camara.leg.br/legin/fed/medpro/2025/medidaprovisoria-1301-30-maio-2025-797527-publicacaooriginal-175524-pe.html. Acesso em: 25 maio 2026.

FREITAS, C. M. *et al.* Conquistas, limites e obstáculos à redução de riscos ambientais à saúde nos 30 anos do Sistema Único de Saúde. **Ciência & Saúde Coletiva**, [online], v. 23, n. 6, p. 1981–1996, 2018. Disponível em: www.scielo.br/pdf/csc/v23n6/1413-8123-csc-23-06-1981.pdf. Acesso em: 16 mar. 2026.

GIOVANELLA, L.; FRANCO, C. M.; ALMEIDA, P. F. de. Política Nacional de Atenção Básica: para onde vamos? **Ciência & Saúde Coletiva**, [online], v. 25, n. 4, p. 1475–1482, 2020. Disponível em: www.scielo.br/j/csc/a/TGQXJ7ZtSNT4BtZJgxYdjYG/?lang=pt. Acesso em: 25 maio 2026.

SILVA, A. C. *et al.* **Saúde e qualidade de vida de caminhoneiros**. Curitiba: Editora Científica Digital, 2022. Disponível em: <https://downloads.editoracientifica.com.br/articles/220308367.pdf>. Acesso em: 18 fev. 2026.

SOUZA, T. S.; VIRGENS, L. S. Saúde do trabalhador na Atenção Básica: interfaces e desafios. **Revista Brasileira de Saúde Ocupacional**, São Paulo, n. 38, v. 128, p. 292–301, 2013. Disponível em: www.scielo.br/j/rbso/a/ZBBvzDsBkJ3vPFhcJjrQ73G/?lang=pt. Acesso em: 25 maio 2026.

STARFIELD, B. **Atenção Primária**: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e tecnologia. Brasília, DF: UNESCO; Ministério da Saúde, 2002. Disponível em: www.dominionpublico.gov.br/download/texto/ue000039.pdf. Acesso em: 16 mar. 2026.